

Insuficiencia renal crónica

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Normas H. Garrahan – Nefrología de la SAP

“Deterioro lento, progresivo e irreversible de la función renal con disminución del FG”

Etiología (en orden de frecuencia)

1. Malformaciones congénitas del riñón y de la vía urinaria.
2. S.U.H.
3. Glomerulopatías

Clínica (no siempre presentes)

- Poliuria inicial por hiperfiltración de nefronas que quedan funcionantes, la manifestación clínica puede ser la enuresis. Retardo del crecimiento
- Dolor óseo
- Piel y mucosas: palidez; observar relleno capilar.
- Osteoarticular: signos de osteodistrofia (por aumento de la PTH) y raquitismo renal (por déficit de vitamina D); cierre tardío de fontanela en lactantes, engrosamiento de cartílago costal, genu valgo.
- Aparato cardiovascular: valorar presencia o no de compromiso hemodinámico: F.C., ritmo cardíaco, hepatomegalia, etc.,
- Aparato respiratorio: F.R. aumentada (aunque no siempre) en acidosis metabólica; presencia de rales crepitantes bibasales o generalizados por sobrecarga hídrica.
- Tensión Arterial. Valorar el estado de hidratación.
- Peso (generalmente disminuido). Talla (generalmente disminuida).

Laboratorio

- **Hemograma:** anemia normocrómica y normocítica por déficit de eritropoyetina
- **Urea, creatinina:** aumentadas
- **Sodio:** hay natriuresis, originando un balance negativo de sodio. Hay una disminución en la capacidad de adaptación tubular rápida a la sobrecarga o restricción brusca de sodio con riesgo de sobrecarga de volumen o contracción del espacio vascular.
- **Potasio:** homeostasis conservada hasta que la insuficiencia renal esta en fases avanzadas, aumentando la excreción renal y digestiva. Hay incapacidad de responder a una carga excesiva de potasio y pueden desarrollar hiperkaliemia severa.
- **EAB:** acidosis metabólica debida a la inhabilidad de excretar hidrogeniones, aumento de la carga acida endógena por la disminución de síntesis de amonio en el segmento distal de la nefrona y en ocasiones por perdida renal de bicarbonato.
- **Fosfatemia: disminuida** en pacientes con I.R.C leve-moderada (el aumento de PTH disminuye la reabsorción de fósforo). Cuando el filtrado glomerular disminuye a menos de 30 ml/min/1.73, ocurre retención, y desarrollo de **hiperfosfatemia**.
- **Calcemia:** generalmente disminuida en forma paralela al aumento de la fosfatemia.
- **Hepatograma con FAL:** es útil en el manejo de niños con osteodistrofia renal, particularmente como seguimiento de respuesta terapéutica.
- **PTH** aumentada.
- **Orina completa:** densidad disminuida, menor o igual a 1010, proteinuria++ o mayor
- **Orina de 24 hs:** proteinuria (Marcador de Enfermedad Renal), Sin control de esfínteres: Índice proteinuria/creatininuria

	Clearance de creatinina	% de nefronas funcion
IRC leve	80-50 ml/min/1,73m ²	50%
IRC moderada	49-25 ml/min/1,73m ²	25-50%
IRC grave	25-10 ml/min/1,73m ²	25-5%
IRCT	<10 ml/min/1,73m ²	<5%

- **Proteinograma**
- **Acido úrico**
- **Serología: HIV, Hepatitis B y C**

Radiología

- Tele Rx tórax frente de pie valorando el índice cardiotorácico
- Huesos: reabsorción ósea en periostio y endostio del hueso cortical: erosión subperióstica de falanges, extremo distal de clavícula y cráneo. La neoformación de hueso (neostosis periosteal) es otro signo asociado a hiperparatiroidismo severo.

Tratamiento

- Dieta normoproteica hipercalórica
La Anorexia es uno de los mayores problemas que plantea el paciente urémico. La generalización de las sondas de gastrostomía permite llevar a cabo el aporte nutricional y calórico de estos niños.
- Potasio: restringido, sobre todo en estadios avanzados de la enfermedad.
- Sodio: en general no suele estar restringido en la IRC, salvo en casos de HTA, síndrome nefrótico o en situaciones muy terminales.
- Restricción de fosforo. Cuando el filtrado glomerular es igual o menor a 60 - 70 ml/min/1,73 m² se indican quelantes de fósforo.
- Análogos de vitamina D: se indica cuando el clearance menor o igual a 60-70-ml/min/1.73 m²)
- Hierro: 1 mg/kg/día
- Acido Fólico: 1-2mg/día vía oral.
- Complejo vit. B vía oral.
- Eritropoyetina Recombinante
- HTA:
 - Restricción del sodio en la dieta
 - Diuréticos: Tiazidas y Furosemida en IRC avanzada
 - IECA